الأداة 3 / 5

الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري

سني أم عظمي أم وظيفي؟ من الأرحاء والأنياب إلى التحليل السيفالومتري، تفرّق بينها خلال دقيقتين بمقارنة جنبًا إلى جنب.

الفصل 1

الصنف الثاني: سني أم عظمي؟

علاقة الأرحاء نفسها من الصنف الثاني قد تنشأ عن أسباب عدة. والعلاج يتبع السبب.

علاقة الأرحاء تفتح الطريق، وANB وWits والجانبية تضع التشخيص. وتعويض القواطع يكشف إن كان التراكب الأفقي يخفي التباين الحقيقي.

داخل الفم

الصنف الثاني السني	الصنف الثاني العظمي
• أرحاء وأنياب صنف ثانٍ؛ غالبًا هجرة أنسية علوية (فقد مبكر لرحى لبنية، فقد مسافة) • زيادة التراكب الأفقي من ميلان القواطع العلوية أماميًا أو الدياستيما • الصنف الثاني أحادي الجانب شائع؛ مع انحراف الخط الناصف	• أرحاء وأنياب صنف ثانٍ، متشابهة في الجانبين • تراكب أفقي كبير؛ في القسم 2: قواطع مركزية علوية مائلة خلفيًا، تراكب أفقي صغير، عضة عميقة واضحة • القواطع السفلية مائلة أماميًا (تعويض)

التحليل السيفالومتري

الصنف الثاني السني	الصنف الثاني العظمي
• ANB ضمن الطبيعي (~2° ± 2) • Wits قريب من الطبيعي • SNA ~82° وSNB ~80° تقريبًا • U1-SN قد يزيد؛ IMPA قريب من الطبيعي	• ANB فوق 4° • Wits زائد إيجابيًا • SNB منخفض (تراجع الفك السفلي، الأشيع) و/أو SNA مرتفع (بروز الفك العلوي) • IMPA زائد: القواطع السفلية تعوّض

الوجه

الصنف الثاني السني	الصنف الثاني العظمي
• جانبية مستقيمة أو محدبة قليلًا • ذقن طبيعية؛ الشفتان تنطبقان بارتياح، أو تتقدم العليا فقط	• جانبية محدبة، ذقن متراجعة، خط عنق–ذقن قصير • توتر الذقنية عند إغلاق الشفتين؛ قد تقع الشفة السفلى خلف القواطع العلوية

اختبار العضة البنائية

اطلب من المريض تقديم الفك السفلي حتى علاقة أنياب من الصنف الأول، وانظر من الجانب. إن تحسنت الجانبية بوضوح فالمشكلة غالبًا في الفك السفلي؛ ولدى من ينمو يُطرح الجهاز الوظيفي (Twin Block، Herbst). وإن ساءت (برزت الذقن) فالمشكلة في الفك العلوي أو سنية.

الفصل 2

الصنف الثالث: سني أم عظمي أم كاذب؟

في الصنف الثالث احتمال ثالث: الصنف الثالث الكاذب الناتج عن انزلاق وظيفي للأمام. استبعده أولًا.

داخل الفم

الصنف الثالث السني	الصنف الثالث العظمي
• أرحاء صنف ثالث أو أول؛ عضة معكوسة أمامية في سن أو بضع أسنان • قواطع علوية مائلة خلفيًا وسفلية مائلة أماميًا (وهذا هو السبب) • لا تباين عظمي بين القوسين	• أرحاء وأنياب صنف ثالث، متشابهة في الجانبين • تراكب أفقي سلبي أو عضة حد لحد؛ غالبًا عضة معكوسة خلفية • قواطع علوية مائلة أماميًا وسفلية مائلة خلفيًا (تعويض)

التحليل السيفالومتري

الصنف الثالث السني	الصنف الثالث العظمي
• ANB ضمن الطبيعي • Wits قريب من الطبيعي • SNA وSNB قريبان من الطبيعي • ميلان القواطع هو مصدر المشكلة	• ANB 0° أو سلبي • Wits زائد سلبيًا • SNA منخفض (تراجع الفك العلوي) و/أو SNB مرتفع (بروز الفك السفلي) • IMPA منخفض: القواطع السفلية مائلة خلفيًا

الوجه

الصنف الثالث السني	الصنف الثالث العظمي
• جانبية مستقيمة؛ ثلث أوسط ممتلئ • ذقن متوازنة	• جانبية مقعرة؛ ثلث أوسط مسطح أو غائر، ذقن بارزة • الشفة السفلى أمام العليا؛ التجمع العائلي شائع

تفريق الصنف الثالث الكاذب: اختبار العلاقة المركزية

الصنف الثالث الكاذب (وظيفي)	الصنف الثالث العظمي الحقيقي
• في العلاقة المركزية يمكن جلب القواطع حد لحد • عند الإغلاق تماس أمامي مبكر ثم ينزلق الفك السفلي للأمام • في العلاقة المركزية علاقة الأرحاء قريبة من الصنف الأول • في العلاقة المركزية تتحسن الجانبية • قواطع علوية مائلة خلفيًا، وسفلية طبيعية أو مائلة أماميًا قليلًا	• يبقى التراكب الأفقي السلبي في العلاقة المركزية أيضًا • انزلاق معدوم أو ضئيل؛ العلاقة المركزية والإغلاق المعتاد متطابقان • أرحاء صنف ثالث في الوضعين • جانبية مقعرة في الوضعين • تعويض سني واضح

1 **أرخِ المريض** – أجلسه مستقيمًا والرأس مستقيم؛ واطلب منه إرخاء عضلات الفك.

2. **وجّه الفك السفلي** – من الذقن برفق للخلف وللأعلى؛ دون إجبار.
3. **راقب التماس الأول** – هل يحدث على القواطع؟ هل تصبح حد لحد؟
4. **قِس الانزلاق** – سجّل مقدار تقدم الفك السفلي من التماس الأول حتى الإغلاق الكامل.
5. **قارن الجانبية في الوضعين** – الجانبية في العلاقة المركزية وفي الإغلاق المعتاد.

خطأ شائع

تشخيص صنف ثالث عظمي من تحليل سيفالومتري في الإغلاق المعتاد. مع الانزلاق الوظيفي يبدو الفك السفلي متقدمًا وANB أسوأ من الواقع. سجّل الانزلاق سريريًا وكيّف التقييم وفقه.

لدى المريض في طور النمو

في الصنف الثالث المبكر مع تراجع الفك العلوي، يفيد قناع الوجه – مع RME عند الحاجة – إن بدأ في وقته. ومع بروز الفك السفلي تلزم المتابعة حتى نهاية النمو ومناقشة الجراحة التقويمية للفكين.

الفصل 3

جدول الخلاصة: اطبعه وعلّقه

اكتب قيمة المريض في العمود الأخير. وابدأ من حيث تقع الأغلبية.

المعيار	II سني	II عظمي	III سني	III عظمي	III كاذب	المريض
الأرحاء / الأنياب	II، غالبًا أحادي	II، ثنائي	I–III	III، ثنائي	في المركزية قرب I	
التراكب الأفقي	زائد (القواطع)	زائد (صغير في القسم 2)	بضع أمامية معكوسة	سلبي / حد لحد	في المركزية حد لحد	
ANB	2 ± 2°~	4° <	2 ± 2°~	0° ≥	في المركزية ~طبيعي	
Wits	قرب الطبيعي	إيجابي، زائد	قرب الطبيعي	سلبي، زائد	في المركزية ~طبيعي	
SNA / SNB	82°~ / 80°~	SNB منخفض و/ أو SNA مرتفع	قرب الطبيعي	SNA منخفض و/ أو SNB مرتفع	قرب الطبيعي	
الجانبية	مستقيمة أو محدبة قليلًا	محدبة، ذقن متراجعة	مستقيمة	مقعرة	تتحسن في المركزية	
القاطعة العلوية	ميلان أمامي	بارزة (ق 1)، مائلة خلفيًا (ق 2)	مائلة خلفيًا	ميلان أمامي (تعويض)	مائلة خلفيًا	
القاطعة السفلية (IMPA)	90°~	زائد (تعويض)	ميلان أمامي	منخفض (تعويض)	طبيعي / زائد قليلًا	
اختبار العضة	التقديم يسيء الجانبية	التقديم يحسّن الجانبية	لا انزلاق	لا انزلاق	في المركزية حد لحد	
الفكرة الأولى	ميكانيكا سنية، إدارة المسافة	جهاز وظيفي لمن ينمو؛ لاحقًا تمويه أو جراحة	تصحيح ميلان القواطع	قناع وجه لمن ينمو؛ لاحقًا تمويه أو جراحة	تصحيح مبكر للعضة المعكوسة الأمامية	

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

بعد التشخيص افتح فصل **الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث**.
ولدى المريض في طور النمو راجع الحالة المشابهة في **الدليل 5 · الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين**، ثم دوّن الخطة في أوراق **الأداة 4 · المخطِّط السريري ذو المراحل الأربع**.